

CAGRILINTIDE

Análogo de Amilina de Larga Acción · IcoSema · Novo Nordisk

10 mg

AMYLIN ANALOG · GLP-1 COMBO · WEIGHT LOSS · RESEARCH GRADE

Cagrilintide es un **análogo sintético de larga acción de la amilina**, una hormona co-secretada con la insulina por las células beta pancreáticas. Desarrollado por Novo Nordisk, actúa por una vía **completamente diferente** a los agonistas GLP-1: reduce el apetito a través del área postrema y del núcleo del tracto solitario. Combinado con semaglutida (CagriSema / IcoSema), logra pérdidas de peso de hasta **25.2% en 32 semanas**.

MECANISMO DE ACCIÓN

AMILINA REC.	Agonista del Receptor de Amilina (CALCR/RAMP) Se une a los receptores de amilina (complejos CALCR+RAMP1/2/3) en el área postrema y el núcleo del tracto solitario (NTS), activando señales de saciedad independientes del GLP-1. Vida media de ~7 días gracias a su modificación con ácido graso C20.
SACIEDAD CENTRAL	Supresión del Apetito por Vía Complementaria al GLP-1 Reduce el apetito y la ingesta calórica activando circuitos neuronales distintos a los del GLP-1. Esto crea un efecto aditivo o sinérgico cuando se combina con semaglutida o tirzepatida.
VACIADO GÁSTR.	Ralentización del Vaciado Gástrico Frena el vaciamiento gástrico postprandial, prolongando la sensación de saciedad y atenuando los picos de glucemia postprandial, complementando el efecto del GLP-1.
GLUCOSA PANCR.	Regulación Glucémica Suprime la secreción postprandial de glucagón pancreático, reduciendo la producción hepática de glucosa. Complementa la acción insulínica del GLP-1 con un mecanismo glucagonostático adicional.

BENEFICIOS CLÍNICOS INVESTIGADOS

Área	Beneficio investigado
■ ■ Pérdida de peso	Hasta 10.8% de pérdida de peso como monoterapia (SCALE). Hasta 25.2% en combinación con semaglutida (CagriSema, Fase 2).
■ ■ Control del apetito	Reducción significativa del hambre y los antojos. Efecto complementario al GLP-1: actúa sobre circuitos neuronales distintos.

CAGRILINTIDE

Análogo de Amilina de Larga Acción · IcoSema · Novo Nordisk

10 mg

AMYLIN ANALOG · GLP-1 COMBO · WEIGHT LOSS · RESEARCH GRADE

Área	Beneficio investigado
■ ■ Glucemia	Mejora el control glucémico postprandial mediante supresión del glucagón y ralentización del vaciado gástrico.
■ ■ Perfil metabólico	Mejora triglicéridos, presión arterial y circunferencia abdominal. Reduce la grasa visceral.
■ ■ Masa muscular	En combinación con GLP-1, preserva mejor la masa muscular magra durante la pérdida de peso respecto a semaglutida sola.
■ ■ Saciedad nocturna	Su larga vida media (~7 días) mantiene la supresión del apetito de forma estable, incluyendo snacking nocturno y emocional.

La combinación ganadora — Cagrilintide + Semaglutida (CagriSema / IcoSema):

- **Semaglutida** (GLP-1): reduce apetito + mejora glucemia + frena vaciado gástrico
 - **Cagrilintide** (Amilina): reduce apetito por vía diferente + suprime glucagón
- Juntos: hasta **25.2% de pérdida de peso** en 32 semanas (Fase 2), superando a semaglutida sola (~15%) y acercándose al Retatrutide (~24%). Actualmente en Fase 3 con el nombre comercial **IcoSema®**.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

1	Preparar materiales Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.
2	Limpiar con alcohol Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.
3	Cargar el agua Con la jeringa, extrae 2 ml de agua bacteriostática.

CAGRILINTIDE

Análogo de Amilina de Larga Acción · IcoSema · Novo Nordisk

10 mg

AMYLIN ANALOG · GLP-1 COMBO · WEIGHT LOSS · RESEARCH GRADE

4

Añadir al vial del péptido

Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

5

Disolver suavemente

Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido.

6

Conservar correctamente

Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **45 días** gracias al agua bacteriostática.

REFERENCIA DE DOSIFICACIÓN

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	2 ml
Concentración resultante	5 mg/ml
Dosis típica	0.3–2.4 mg por inyección (una vez a la semana · escalada progresiva)
Unidades en jeringa 100U	6–48 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) · Abdomen o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C · Máx. 45 días

■ ■ **Protocolo de escalada:** Semanas 1-4: 0.3 mg (6 U) · Semanas 5-8: 0.6 mg (12 U) · Semanas 9-12: 1.2 mg (24 U) · Semanas 13+: 2.4 mg (48 U) según tolerancia.
Administrar **una vez por semana**, el mismo día. El vial de 10 mg rinde **4 dosis** a la dosis máxima de 2.4 mg o hasta **33 semanas** a la dosis inicial de 0.3 mg. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8°C) máx. **45 días** con agua bacteriostática.